

TEMA 3.12 • OBSTETRICIA

Aborto Completo vs. Embarazo Ectópico Roto

PERFIL EUNACOM 2.01.2.010
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Aborto Completo vs. Embarazo Ectópico Roto

Escenario clínico que genera confusión

Paciente con: **metrorragia + test de embarazo (+) + ecografía transvaginal sin embarazo intrauterino**
→ ¿Aborto completo (ya expulsado)? ¿O embarazo ectópico roto (sangrado activo)?

Diagnóstico Diferencial

TABLA 3.12.1: CARACTERÍSTICA VS ABORTO COMPLETO		
CARACTERÍSTICA	ABORTO COMPLETO	EMBARAZO ECTÓPICO ROTO
Cuello uterino	Abierto / modificado (ya expulsó)	Cerrado, duro
Hemodinamia	Estable siempre	Puede deteriorarse → shock hipovolémico
Evolución	Mejora después de expulsar los restos	Empeora progresivamente
Eco: contenido endometrial	< 15 mm (ya abortó)	< 15 mm también (útero vacío)
Eco: líquido libre peritoneal	Generalmente no	Sí (sangre en cavidad peritoneal)

Manejo

TABLA 3.12.2: DIAGNÓSTICO VS CONDUCTA	
DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Aborto completo	Observación (no se hace nada más)
Ectópico roto	Cirugía urgente (laparoscopia o laparotomía según estado hemodinámico y disponibilidad)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundirlos — el manejo es opuesto. El aborto completo no requiere intervención; el ectópico roto requiere cirugía urgente.
Clave diferencial: cuello cerrado + líquido libre + inestabilidad hemodinámica → ectópico roto.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Aborto Completo vs. Embarazo Ectópico Roto. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Escenario clínico que genera confusión
- Diagnóstico Diferencial
- Manejo
- Embarazo ectópico roto
- | Abierto / modificado (ya expulsó) |
- siempre | Puede deteriorarse → shock hipovolémico | |
- | Mejora después de expulsar los restos | Empeora progresivamente | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABORTO COMPLETO VS. EMBARAZO ECTÓPICO ROTO)

PREGUNTA 1

Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?

- A)** Legrado uterino por aborto incompleto
- B)** Metotrexato intramuscular — paciente hemodinámicamente estable con criterios
- C)** Esperar evolución espontánea (expectante)
- D)** Laparotomía de urgencia
- E)** Repetir beta-HCG en 48h y si dobla, hospitalizar

PREGUNTA 2

Mujer de 25 años con embarazo ectópico. Llega con PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, abdomen en tabla y dolor generalizado. ¿Conducta inmediata?

- A)** Metotrexato IM y observación 24h
- B)** Beta-HCG urgente para confirmar el diagnóstico
- C)** Laparoscopia/laparotomía de urgencia con reanimación simultánea
- D)** Transfusión de 2 unidades de GR y observar respuesta
- E)** Ecografía TV para confirmar localización antes de operar

PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico?

- A)** Multiparidad
- B)** Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o cirugía tubárica previa
- C)** Uso de anticonceptivos orales combinados
- D)** Nuliparidad
- E)** Síndrome de ovario poliquístico

RESUMEN: ABORTO COMPLETO VS. EMBARAZO ECTÓPICO ROTO

⚠ No confundirlos — el manejo es opuesto. El aborto completo no requiere intervención; el ectópico roto requiere cirugía urgente.